

TEMA 9.1 • RESPIRATORIO

Infecciones Respiratorias Altas

PERFIL EUNACOM 1.04.1.016

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definiciones

Es fundamental distinguir entre el agente etiológico y la enfermedad clínica. La **COVID-19** es la enfermedad causada por el coronavirus descubierto en el año 2019. El virus propiamente tal se denomina **SARS-CoV-2**.

NOTA CLÍNICA

El nombre **SARS** hace referencia al Síndrome de Dificultad Respiratoria Severa (Severe Acute Respiratory Syndrome), un cuadro de afectación respiratoria habitualmente aguda y grave. El SARS-CoV-2 es evolutivamente distinto al SARS-CoV-1, responsable del brote de SARS en China a principios de los años 2000.

Espectro Clínico

La presentación de la infección por SARS-CoV-2 es sumamente heterogénea, abarcando desde cuadros silentes hasta fallas orgánicas múltiples:

- **Asintomáticos:** Pacientes que portan y transmiten el virus sin desarrollar síntomas.
- **Infección Respiratoria Alta Leve:** Cuadro similar a un resfrío común.
- **Síndrome Gripal:** Caracterizado por fiebre, mialgias, cefalea y compromiso del estado general, muy similar a la **Influenza**.
- **Neumonía Viral / Neumonitis:** Cuadro severo que puede progresar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SARS), requiriendo soporte ventilatorio.

Factores de Riesgo para Progresión Grave

La identificación temprana de pacientes con riesgo de evolucionar hacia una **neumonía grave** es crucial en el manejo inicial.

- **Edad:** Es el factor de riesgo más importante; a mayor edad, mayor es la probabilidad de complicaciones y mortalidad.
- **Factores de Riesgo Cardiovascular:**
 - **Hipertensión Arterial** esencial.
 - **Obesidad** (uno de los predictores más fuertes de mala evolución).
 - Antecedentes de patología cardiovascular previa.
 - **Diabetes Mellitus** tipo 2.
- **Patologías Crónicas:** Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o **Insuficiencia Cardíaca** que presentan una reserva funcional limitada y se descompensan ante la infección viral.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cualquier paciente con comorbilidades cardiovasculares debe ser monitorizado estrechamente, ya que la COVID-19 no solo afecta el pulmón, sino que genera un estado inflamatorio sistémico que descompensa patologías de base.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en pruebas moleculares, de antígenos e imágenes.

Pruebas de Laboratorio

TABLA 9.1.1: EXAMEN VS SENSIBILIDAD

EXAMEN	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD	OBSERVACIONES
PCR (RT-PCR)	~90%	~100%	Gold Standard. Muy sensible y específica.
Test de Antígeno	Menor (Variable)	~100%	Resultado inmediato. Útil principalmente en pacientes con síntomas .

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes asintomáticos, el test de antígeno tiene baja sensibilidad y un resultado negativo no descarta la infección. Sin embargo, en pacientes sintomáticos, su sensibilidad se acerca a la de la PCR, siendo una herramienta de tamizaje rápido muy eficaz.

Diagnóstico por Imágenes

- **Radiografía de Tórax:** Puede sugerir el cuadro (infiltrados intersticiales o alveolares), pero es inespecífica.
- **TAC de Tórax (Scanner):** Es mucho más sensible. Existen patrones radiológicos (como el vidrio esmerilado periférico y bilateral) que son tan característicos que pueden permitir el diagnóstico categórico de COVID-19 incluso antes de contar con la PCR.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento se estratifica según la gravedad del cuadro clínico:

1. Manejo Ambulatorio (Leve)

- **Asintomáticos:** No requieren tratamiento médico, solo aislamiento. - **Sintomáticos leves (Síndrome gripal):** Tratamiento sintomático. El fármaco de elección es el **Paracetamol**.

2. Manejo Hospitalario (Moderado a Grave)

Cuando existe evidencia de neumonía o requerimiento de oxígeno, el manejo se vuelve complejo y de soporte:

- **Corticoides (Dexametasona):** Es uno de los pilares del tratamiento, ya que ha demostrado disminuir significativamente la mortalidad en pacientes que requieren soporte de oxígeno.
- **Heparina de Bajo Peso Molecular (Anticoagulación):** Se utiliza de forma profiláctica (o terapéutica según el caso) para prevenir complicaciones trombóticas asociadas al estado de hipercoagulabilidad de la enfermedad.
- **Soporte Respiratorio:** Desde naricera simple hasta ventilación mecánica invasiva.
- **Antivirales:** Existen fármacos específicos (como el Remdesivir) que se discuten en el contexto de **Neumonía** viral intrahospitalaria.

EUNACOM CRITERIOS

El uso de corticoides está indicado principalmente en pacientes que requieren oxígeno. Su uso en etapas muy precoces o cuadros leves sin hipoxemia podría no ser beneficioso o incluso ser perjudicial.

Prevención

- La estrategia preventiva se divide en dos pilares:
- **Vacunación:** La medida más efectiva para prevenir cuadros graves y muerte.
- **Medidas de Control de Infección:** Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación de espacios, comunes a todas las infecciones respiratorias virales.

Para más detalles sobre complicaciones respiratorias, ver **Neumonía y Insuficiencia Respiratoria**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 28 años consulta por rinorrea acuosa, odinofagia, tos seca y fiebre de 38.2°C de 2 días de evolución. Al examen físico la faringe está eritematosa, hay adenopatías cervicales pequeñas y el examen pulmonar es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infecciones Respiratorias Altas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- IRA = afectación exclusiva de la vía aérea superior. Examen pulmonar estrictamente NORMAL.
- Clínica: rinorrea, disfonía, odinofagia, tos, faringe eritematosa, fiebre, malestar general, adenopatías.
- Diferencia clave con infección respiratoria baja: sin disnea ni desaturación. Si aparecen → sospechar neumonía viral.
- Diagnóstico absolutamente clínico. No requiere exámenes complementarios en condiciones normales.
- Exámenes (Rx tórax, hemograma) NO están indicados en IRA. Si el hemograma muestra algo, es linfocitosis (etiología viral).
- Excepción para exámenes: situaciones epidemiológicas especiales (pandemia) → PCR COVID-19, panel viral.
- Tratamiento 100% sintomático: paracetamol, AINEs si malestar intenso, pseudoefedrina si rinorrea importante.
- Virus más frecuentes: rinovirus, VRS, parainfluenza, COVID-19, metaneumovirus, adenovirus, enterovirus.
- La clínica varía según zona afectada: faringitis, amigdalitis, rinitis, sinusitis, laringitis, traqueítis — todas son IRA.
- NO son IRA: neumonías, bronconeumonías, bronquiolitis y síndrome bronquial obstructivo (son infecciones respiratorias bajas).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 28 años consulta por rinorrea acuosa, odinofagia, tos seca y fiebre de 38.2°C de 2 días de evolución. Al examen físico la faringe está eritematosa, hay adenopatías cervicales pequeñas y el examen pulmonar es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Solicitar radiografía de tórax y hemograma
- B)** Indicar amoxicilina 500mg cada 8 horas por 7 días
- C)** Tratamiento sintomático con paracetamol y descongestionantes
- D)** Solicitar PCR para COVID-19 de forma obligatoria
- E)** Iniciar oseltamivir empírico por sospecha de influenza

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años con cuadro de 3 días de rinorrea, tos productiva y fiebre. Al examen presenta faringe eritematosa y examen pulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra leucocitos 8.500/mm³ con 55% linfocitos. ¿Cuál es la interpretación más correcta?

- A)** Linfocitosis sugerente de leucemia linfocítica
- B)** Hemograma compatible con infección viral, aunque el examen no estaba indicado
- C)** Hemograma normal, se descarta infección
- D)** Neutropenia que requiere estudio hematológico urgente
- E)** Leucocitosis con desviación izquierda sugerente de infección bacteriana

PREGUNTA 3

Paciente de 42 años con diagnóstico de resfrío común de 4 días de evolución, consulta nuevamente porque ahora presenta disnea, desaturación a 91% y crepitaciones bibasales al examen pulmonar. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

- A)** Infección respiratoria alta en evolución normal
- B)** Reacción alérgica a los descongestionantes
- C)** Neumonía viral como complicación de la IRA
- D)** Bronquitis aguda sin mayor importancia
- E)** Exacerbación de asma no diagnosticada

RESUMEN: INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS

Las infecciones respiratorias altas (IRA) son cuadros virales que afectan exclusivamente la vía aérea superior. Su clínica es la de un resfriado común: rinorrea, disfonía, odinofagia, tos (seca o productiva), faringe eritematosa, y pueden acompañarse de fiebre, malestar general y adenopatías. Los agentes causales más frecuentes son rinovirus, VRS, parainfluenza, COVID-19 y otros coronavirus, metaneumovirus y adenovirus. Lo fundamental que diferencia una IRA de una infección respiratoria baja es que el examen pulmonar es estrictamente normal: no hay disnea ni desaturación. Si aparecen estos síntomas, se debe sospechar una complicación como neumonía viral. Los exámenes complementarios (radiografía de tórax y hemograma) NO están indicados en una IRA, salvo en situaciones epidemiológicas excepcionales donde se busca el agente etiológico (PCR COVID-19, panel viral para influenza). El diagnóstico es clínico y el tratamiento es exclusivamente sintomático: paracetamol, antiinflamatorios si hay malestar intenso, y descongestionantes como pseudoefedrina. La clínica varía según la zona más inflamada de la vía aérea superior (faringitis, amigdalitis, rinitis, sinusitis, laringitis, traqueítis), pero todas son la misma entidad. Es importante recordar que neumonías, bronconeumonías, bronquiolitis y síndrome bronquial obstructivo NO son IRA, sino infecciones respiratorias bajas.